

Requerimientos Legales y Técnicos para Historia Clínica Psiquiátrica Electrónica

Guía de Cumplimiento Normativo y Diseño de Software para la República Argentina

Área: Arquitectura de Software • Especialidad: Salud Mental / Psiquiatría • Versión: 1.0

1. Marco Normativo General

El desarrollo e implementación de un sistema de Historia Clínica Electrónica (HCE) para psiquiatría en Argentina debe fundamentarse en el cumplimiento estricto y concurrente de cinco leyes troncales:

Ley / Regulación	Objeto Principal	Impacto en el Software
Ley 26.529 Derechos del Paciente	Autonomía de la voluntad, confidencialidad, titularidad del paciente sobre su historia clínica.	Requisitos formales de contenido, inalterabilidad de los registros, derecho a copia y guarda por 10 años.
Ley 27.706 HCE Federal	Marco legal de interoperabilidad y obligatoriedad de historias clínicas electrónicas en todo el país.	Estándares técnicos abiertos, intercambio seguro de datos de salud e identificación única.
Ley 26.657 Salud Mental	Garantía de derechos humanos en salud mental, interdisciplinariedad y consentimiento.	Consentimientos explícitos, justificación estricta de riesgo e internación, acceso multidisciplinar.
Ley 25.326 Datos Personales	Protección integral de datos personales y sensibles (Habeas Data).	Cifrado fuerte en reposo/tránsito, acceso restringido, secreto profesional digital.
Ley 25.506 Firma Digital	Validez jurídica y equiparación de firma digital a la firma ológrafa.	Mecanismo criptográfico PKI para firma de evoluciones, recetas y epicrisis.

2. Contenido Asistencial Obligatorio (Estructura de Datos)

Toda ficha clínica debe contener información estructurada que garantice la trazabilidad del proceso asistencial:

A. Datos Filiatorios y Administrativos

- Paciente:** Nombre y apellido completo, DNI/Pasaporte, CUIL/CUIT, fecha de nacimiento, domicilio real, cobertura de salud (obra social/prepaga y N° de afiliado), y datos de contacto de emergencia o representante legal.
- Profesional tratante:** Nombre, DNI, matrícula nacional y/o provincial, especialidad médica y firma digital.

B. Registro Clínico Psiquiátrico

- Anamnesis y Motivo de Consulta:** Relato cronológico del padecimiento, antecedentes personales somáticos y psiquiátricos, antecedentes heredofamiliares, toxicología y medicación previa.
- Examen Psiquiátrico del Estado Actual (Semiología):** Registro de conciencia, orientación témporo-espacial, atención, memoria, sensopercepción, curso y contenido del pensamiento, afectividad, juicio y conducta.
- Diagnóstico y Diagnóstico Diferencial:** Codificación estandarizada mediante **CIE-10 / CIE-11** o **DSM-5**.
- Plan Terapéutico y Farmacología:** Denominación Genérica de psicofármacos, posología, vía de administración, duración prevista del tratamiento y monitoreo de efectos adversos o interacciones.
- Evoluciones:** Registro fechado y con hora exacta de cada sesión, modificaciones de esquema o interconsultas.

3. Requisitos Críticos de Salud Mental (Ley 26.657)

Punto Crítico: Calificación de Riesgo Cierto e Inminente

En caso de intervenciones en crisis o indicación de internación involuntaria, el sistema debe exigir un campo estructurado y no omitible donde el profesional (y el equipo interdisciplinario) fundamente técnicamente la presencia de **riesgo cierto e inminente** para sí o para terceros, con notificación formal a los órganos de revisión en los plazos legales.

- **Consentimiento Informado:** Módulo para adjuntar o suscribir digitalmente el consentimiento informado previo a cualquier modificación de tratamiento farmacológico de relevancia o procedimiento asistencial.
- **Directivas Anticipadas en Salud Mental:** Campo específico para registrar la voluntad anticipada del paciente en cuanto a decisiones de tratamiento durante eventuales períodos de pérdida de capacidad de discernimiento.
- **Abordaje Interdisciplinario:** La plataforma debe permitir el registro concurrente de evoluciones por parte de otros miembros del equipo tratante (psicología, trabajo social, enfermería) manteniendo autoría individual.

4. Arquitectura de Seguridad, Integridad y Auditoría (Software)

Componente	Especificación Técnica y Regulatoria
Inalterabilidad de Registros	Prohibición estricta de borrado lógico o físico (<i>soft/hard delete</i>) de evoluciones firmadas. Cualquier enmienda debe registrarse como un nuevo evento clínico ("Fe de erratas" o "Aclaración") referenciado al ID de la entrada original.
Pistas de Auditoría (Audit Logs)	Registro inmutable y detallado de cada acción: <i>Lectura (Read)</i> , <i>Creación (Create)</i> , <i>Exportación (Export)</i> . Se debe almacenar: ID de usuario, IP de origen, timestamp UTC certificado, ID de registro y acción ejecutada.
Control de Acceso (RBAC)	Segmentación estricta de permisos según rol profesional. El personal administrativo no debe tener acceso a las notas clínicas/psiquiátricas, limitándose únicamente a los datos demográficos y de facturación.
Cifrado y Protección de Datos	Cifrado en tránsito mediante protocolos seguros (TLS 1.3 / HTTPS) y cifrado en reposo para bases de datos y blobs adjuntos (AES-256).
Plazo de Conservación	El sistema debe garantizar la preservación, integridad y recuperabilidad de toda la historia clínica por un plazo mínimo legal de 10 años desde la última anotación.
Derecho de Acceso y Exportación	Módulo de exportación para emitir una copia completa, foliada y legible (PDF con firma digital institucional o del profesional) dentro de las 48 horas de solicitada por el paciente o requerimiento judicial.

Interoperabilidad y Estándares de Salud Digital

Para cumplir con la **Ley 27.706** y las normativas del Ministerio de Salud de la Nación, se recomienda diseñar las APIs bajo el estándar **HL7 FHIR R4** y adoptar la terminología clínica estandarizada **SNOMED-CT** para diagnósticos y procedimientos.